

# ICU 年次レポート ダイジェスト 2025年度

対象期間 2025年4月1日 ～ 2026年3月31日にICU入室した **591例** | 作成 2026年8月

## 要旨

入室は**591例**と過去6年で最多、ICU死亡率は**3.4%**まで下がった。重症度で補正した標準化死亡比は**0.63**で、6年連続して「予測より死亡が少ない」水準を保っている。

一方で注意すべき変化が3つある。**再入室率が12.2%**と過去6年で最高になったこと、**院内死亡率が上昇**しICU退室後に亡くなる患者が増えたこと、そして**データ入力**の欠落が一部の質指標を評価不能にしていることである。

## 1. 今年度の全体像

ICU入室患者数

**591** 例

▲ 38 例 前年度 553 例

ICU死亡率

**3.4** %

▼ 1.3 pt 前年度 4.7%

院内死亡率

**15.0** %

▲ 1.4 pt 前年度 13.6%

標準化死亡比 SMR

**0.63**

▲ 0.05 前年度 0.58

再入室率

**12.2** %

▲ 2.8 pt 前年度 9.4%

人工呼吸実施率

**19.5** %

▼ 8.2 pt 前年度 27.7%

ICU在室日数（中央値）

**3** 日

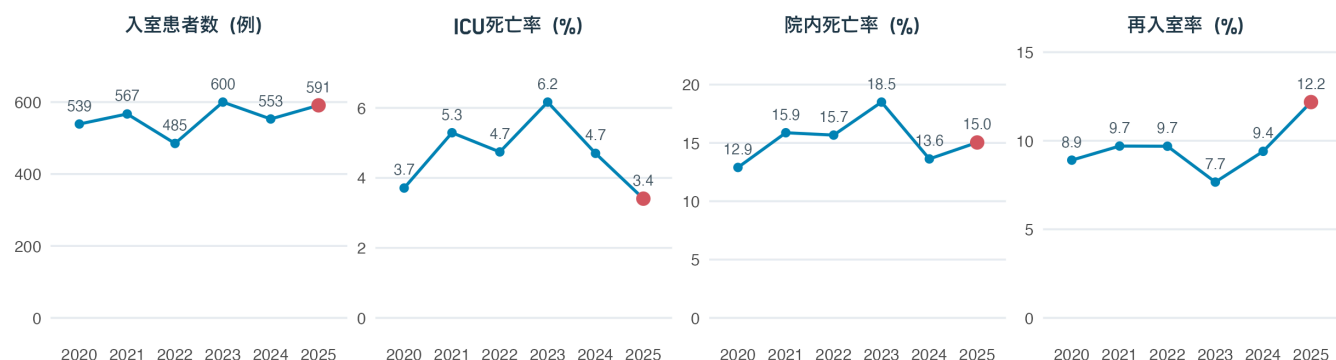
6年間変わらず

1日あたり在室患者数

**8.4** 人

4～12 人の範囲

緑＝改善、赤＝悪化、灰＝良し悪しを判定しない指標。SMR＝院内死亡数 ÷ APACHE III による予測死亡数。



赤い点が今年度。患者数は最多、ICU死亡率は最低。一方で再入室率だけが跳ね上がっている。

## 2. 押さえるべき3つの変化

### 01

#### 患者は増えたが、在室は伸びていない

入室は前年度比+38例の591例。一方で延べ在室日数は3,257日→**3,009日**と減少し、在室日数の中央値は3日で変わらない。15日以上長期滞在も50例→**43例**に減った。

**意味するところ：**同じベッド数でより多くの患者を診た。回転が速くなっており、予定手術の割合が35.8%→**39.6%**に増えたことと整合する。短期で退室できる術後患者が増えた結果と考えられる。

## 02

### ICU死亡率は改善、院内死亡率は悪化

ICU死亡率は4.7%→**3.4%**と改善した。しかし院内死亡率は13.6%→**15.0%**へ上昇している。両者は逆方向に動いた。

意味するところ：ICUを生きて退室した後に亡くなる患者が増えた。ICU内の治療成績だけを見ていると、この変化は見えない。退室判断のタイミング、退室先病棟でのフォロー体制、そして再入室率の上昇（次項）と合わせて検討すべき現象である。

## 03

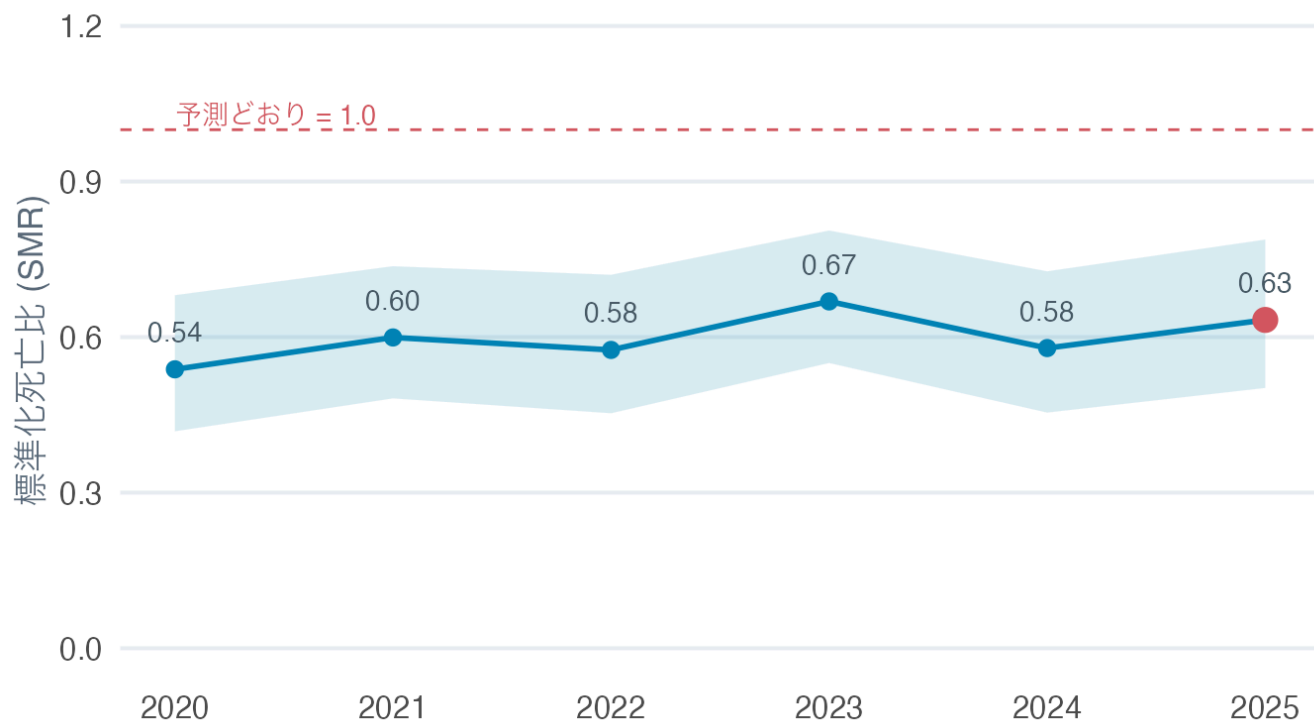
### 再入室率が過去6年で最高

9.4%→**12.2%**へ上昇。これまでの最高は9.7%で、それを明確に上回った。

意味するところ：再入室は「早すぎる退室」の代表的な指標である。回転が速くなったこと（01）、退室後の死亡が増えたこと（02）と同じ方向を指しており、**3つは同一の現象の別の側面である可能性が高い**。個別症例のレビューによる要因分析を推奨する。

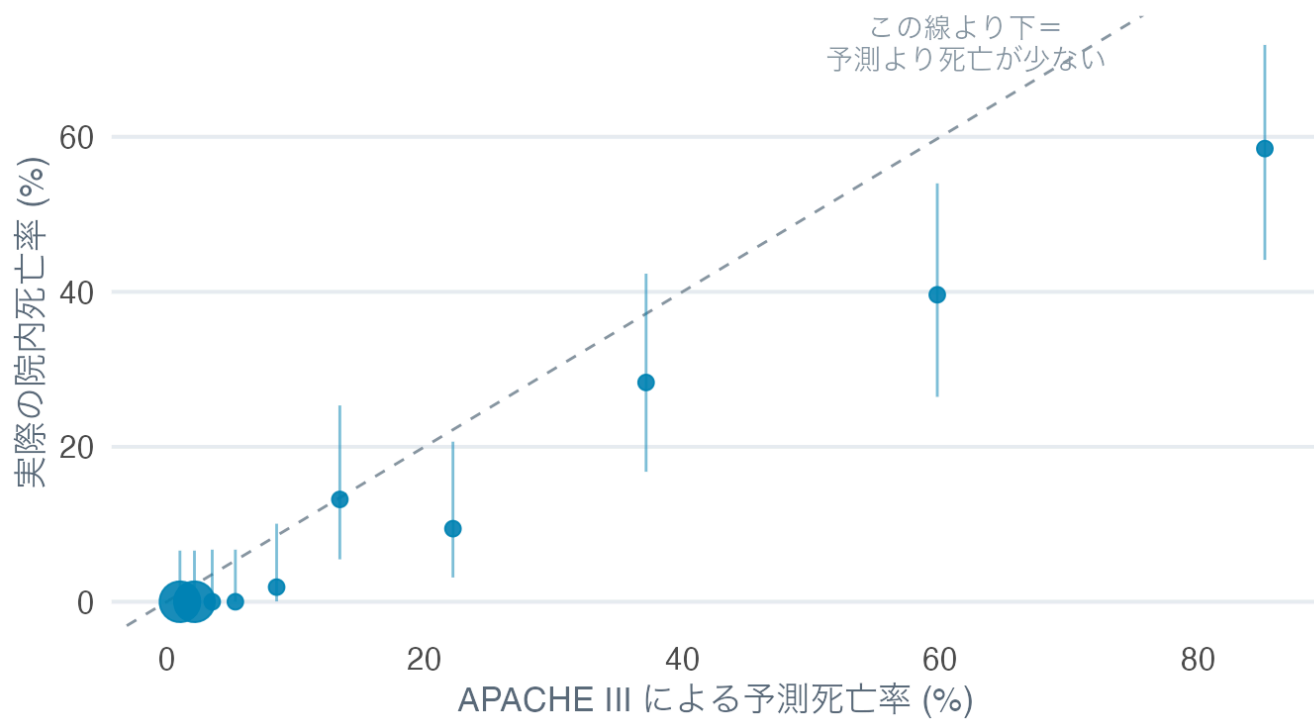
## 3. 診療の質は保たれている

帯は95%信頼区間。6年間すべてで上限が1を下回っている



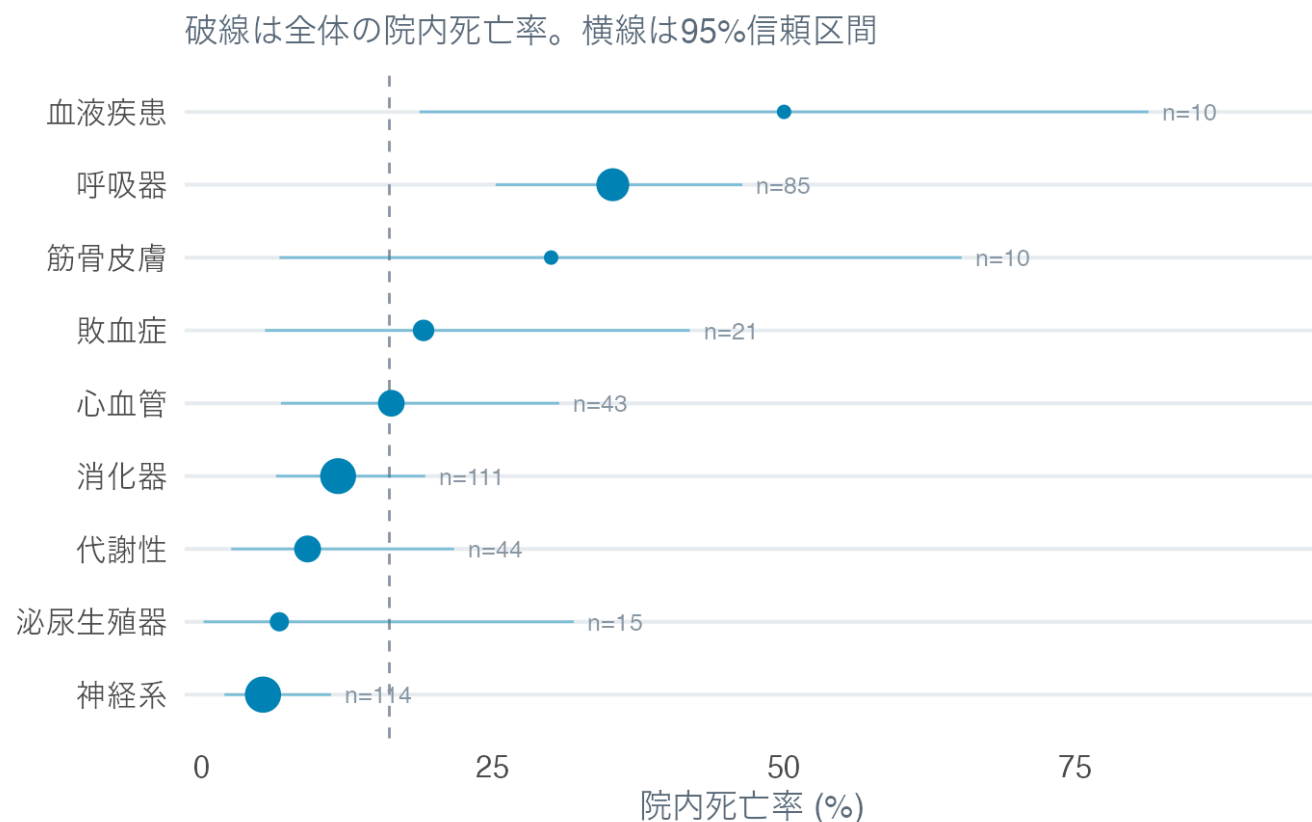
SMRは0.63 (95%信頼区間 0.50~0.79)。6年間つねに信頼区間の上限が1を下回っている。

重症度10段階すべてで、実測が予測を下回った



重症度を10段階に分けた比較。すべての段階で実測が予測を下回った。

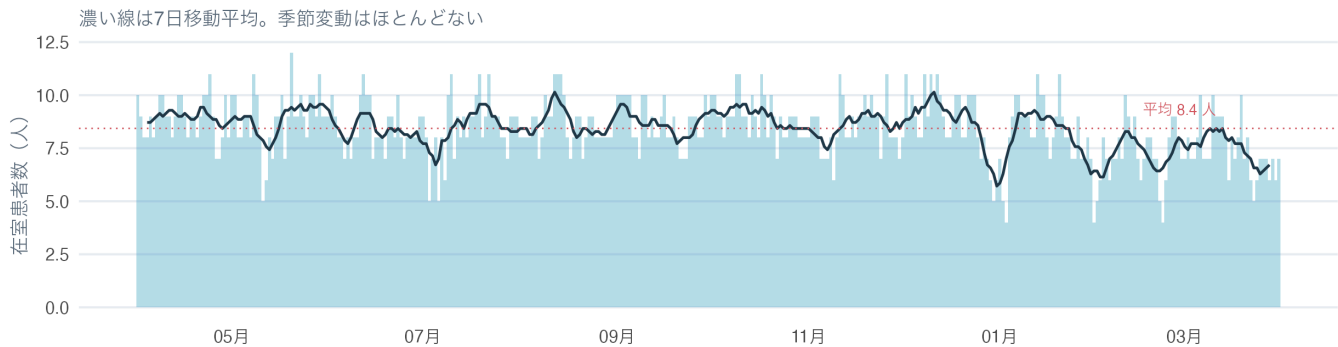
**なぜこれが重要か：**SMRという1つの数字は、患者構成が変われば動く。しかし軽症帯から最重症帯まで一様に予測を下回っているのであれば、それは特定の患者層に偏った結果ではなく、診療全体の水準を反映していると解釈できる。単年度のSMR比較より強い根拠になる。



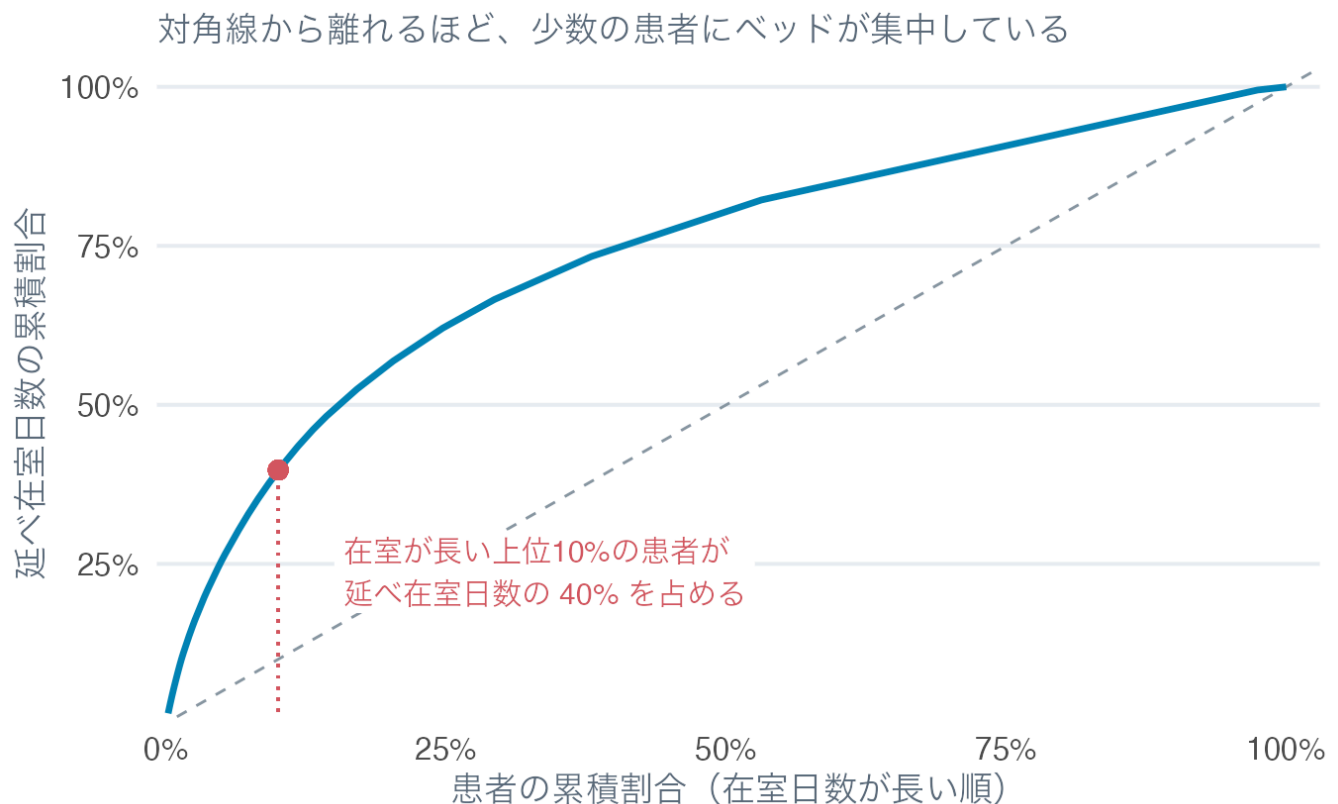
疾患群ごとの院内死亡率。点の大きさは症例数、横線は95%信頼区間。10例以上の群のみ。

**読みどころ：**死亡率が高い群と在室が長い群は一致しない。「死亡は少ないが長期化する群」はベッド運用の課題、「死亡率が高い群」は診療内容の課題として、分けて扱う必要がある。

## 4. 病床は少数の長期滞在患者に支配されている



1日あたり平均8.4人（4～12人）。季節変動はほとんどない。



在室日数の長い上位10%の患者が延べ在室日数の**40%**、上位20%で**56%**を占める。

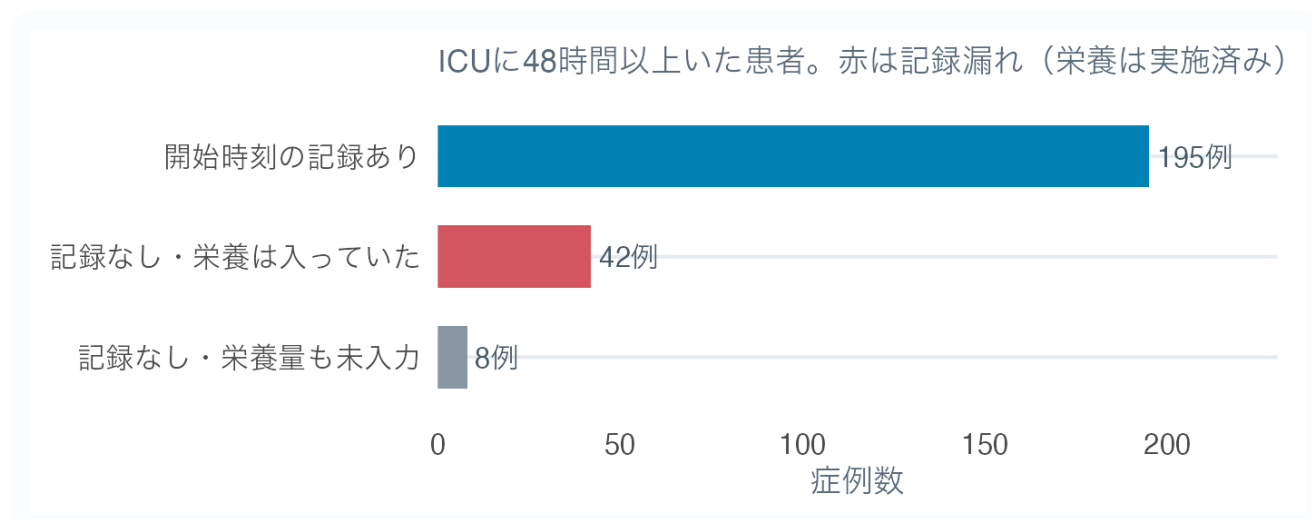
**実務への示唆：**平均在室数8.4人に対して最大12人と、日によって3倍の開きがある。平均を前提に人員を組むと混雑日に負荷が集中する。また**長期滞在患者を1人減らす効果は、短期入室を数人減らす効果より大きい**。病床の余裕をつくる打ち手は、長期滞在患者の管理に集中させるのが合理的である。

## 5. データ入力の欠落が評価を妨げている



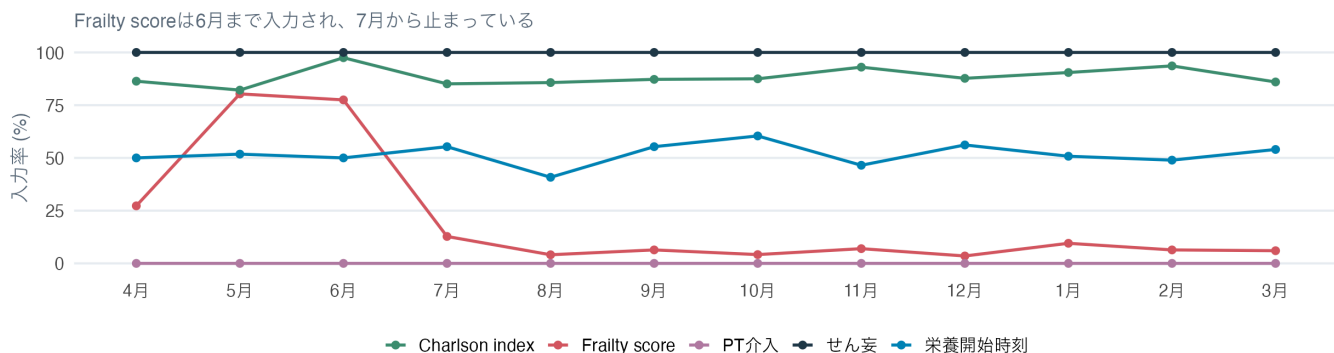
### 栄養データ：昨年度まで実施率を約2倍過小評価していた

「48時間以内の栄養開始」は、昨年度版まで開始時刻が未入力の症例を「開始しなかった」として数えていた。今年度は未入力率が48%あり、この方法では**39.8%**となる。入力がある症例だけで計算すると**76.8%**である。



調べてわかったこと：ICUに48時間以上いた245例のうち、開始時刻の記録がない50例を追跡すると、**42例は実際には栄養が入っていた（記録漏れ）**。「開始しなかったから空欄」という症例は**1件もなかった**。空欄＝未実施という前提が誤っていた。

**正しい評価値**：48時間以上在室した患者に限れば **65.1%**（195例中）。早期経腸栄養というQIは、そもそも48時間以上いる患者でなければ評価できない。これを今後の基準値とすべきである。



Ex-JIPAD項目の月別入力率。**Frailty scoreは6月まで入力され、7月から止まっている。**

**重要な発見：**年間平均だけを見ると「もともと取っていない項目」に見えるが、月別に見るとある月を境に入力が途切れている。Frailty scoreは5～6月に80%近く入力されていた。PT介入は前年度8月から止まったまま1年半以上放置されている。**担当者の交代や手順変更**にさかのぼれる問題であり、項目を諦める前に原因を確認する価値がある。

| 項目                     | 今年度の入力率 | 状況                  |
|------------------------|---------|---------------------|
| せん妄                    | 100%    | 良好                  |
| Charlson index         | 88%     | 良好                  |
| 栄養開始時刻                 | 52%     | 記録漏れが混在。入力ルールの特化が必要 |
| Clinical Frailty Scale | 20%     | 6月まで入力、7月以降停止       |
| PT介入                   | 0%      | 前年度8月から停止したまま       |
| 退室後訪問の対象者              | 0%      | 今年度まったく入力なし         |

台帳由来の項目（重症度スコア・デバイス・転帰）は全年度ほぼ100%完備しており、上記はいずれもEx-JIPAD側で人が入力する項目である。

## 6. 提言



- 1 **再入室12.2%の要因分析を行う。**過去6年で最高であり、院内死亡率の上昇と同じ方向を指している。個別症例のレビューで「早すぎる退室」が起きていないかを確認する。
- 2 **栄養データの入力ルールを管理栄養士と合意する。**「開始したら時刻、開始しなければ理由」を徹底し、空欄を残さない。「開始できなかった理由」欄は現在まったく使われていない（過去には使われていた）。
- 3 **早期経腸栄養の基準値を65.1%（48時間以上在室例）に置き換える。**従来の39.8%は実施率ではなく入力率を映した数字だった。QIダッシュボードも同様に修正する。
- 4 **Ex-JIPAD入力が止まった項目の原因を特定する。**Frailty scoreは7月、PT介入は前年度8月から停止している。月別の入力率を定期的に確認する仕組みを作る。
- 5 **長期滞在患者に的を絞った病床対策を検討する。**上位10%の患者が延べ在室日数の40%を占めており、ここが病床の余裕を決めている。

## 付録：主要数値一覧

| 指標                    | 2025年度               | 2024年度  |
|-----------------------|----------------------|---------|
| 入室患者数                 | 591 例                | 553 例   |
| 延べ在室日数                | 3,009 日              | 3,257 日 |
| ICU在室日数（中央値）          | 3 日                  | 3 日     |
| 年齢（中央値）               | 71 歳                 | —       |
| 男性                    | 54.0%                | —       |
| 予定手術の割合               | 39.6%                | 35.8%   |
| 緊急入室の割合               | 60.6%                | —       |
| ICU死亡率                | 3.4%                 | 4.7%    |
| 院内死亡率                 | 15.0%                | 13.6%   |
| 標準化死亡比（APACHE III）    | 0.63                 | 0.58    |
| 再入室率                  | 12.2%                | 9.4%    |
| 人工呼吸実施率               | 19.5%                | 27.7%   |
| 入室24時間以内の人工呼吸         | 18.4%                | 26.4%   |
| せん妄発生率                | 35.4%                | 42.5%   |
| 15日以上 of 長期滞在         | 43 例                 | 50 例    |
| 48時間以内の栄養開始（48h以上在室例） | 65.1%                | —       |
| 1日あたり在室患者数（平均）        | 8.4 人                | —       |
| 多い疾患群                 | 神経系・消化器・呼吸器          |         |
| 多い診療科                 | 脳神経外科・消化器・一般外科・呼吸器内科 |         |

人工呼吸実施率の低下は入力漏れではない。入力率100%の別項目「入室後24時間以内の人工呼吸」でも 26.4%→18.4%と同方向に動いている。

退院時転帰が未確定の症例が59例あり、院内死亡率とSMRはこれを除いて計算している。

データ出典：20260421ICU症例統合全データ.xlsx / ExJIPAD\_20260421135009.csv。詳細版は「JIPAD\_StLukes\_2025.html」を参照。

---

## 聖路加国際病院 集中治療科 ICU年次レポート 2025年度 ダイジェスト

院内資料。患者個人を特定する情報は含まれていません。